

原位新膀胱（orthotopic neobladder）是用您自身的一段肠道制成的新膀胱，与尿道相连，使您在膀胱切除或失去功能后仍可自然排尿——无需造口袋。学会正确排空新膀胱并恢复控尿能力需要时间和练习。

关于这项手术

医生取出约 **40–60 厘米** 的小肠，将其展开并折叠成低压储尿囊，再与您的**尿道**相连；来自肾脏的输尿管也流入囊内。术后**无需造口，无需造口袋**。

由于新膀胱由肠道构成，它**不会产生**"尿急"的感觉，因此您需要学会：

- 按**时间表**排尿——通过放松盆底肌并轻轻用力——包括**夜间定时起床排尿**。
- 若新膀胱排空不完全，需自行插管导尿（女性更为常见）。
- 坚持做**盆底肌锻炼**，增强控尿能力。

控尿能力会在**数月内**逐步改善；早期出现漏尿（尤其夜间）较为常见。并非所有人都适合此手术，取决于尿道条件、肾功能及日常管理能力。

安全吗？

这是一种成熟的手术方式，能获得最接近"自然"的排尿效果。但手术时间较长、创伤较大，术后需要更多学习和随访。风险包括：出血、感染、吻合口漏、日间或夜间漏尿、排空不完全需导尿、黏液分泌、尿路感染，以及需长期监测的电解质、维生素和肾功能变化。

名词解释

新膀胱（Neobladder）

用一段肠道制成的人工膀胱。

原位（Orthotopic）

放置在原来膀胱的位置并与尿道相连，排尿方式与正常相同。

尿道（Urethra）

尿液排出体外所经过的管道。

输尿管（Ureters）

将肾脏产生的尿液输送至新膀胱的管道。

定时排尿（Timed voiding）

按固定时间表（白天和夜间）排尿，而非等待尿意。

自我导尿（Self-catheterization）

自行插入细管以完全排空新膀胱。

盆底（Pelvic floor）

帮助控制排尿和尿液释放的肌肉群。

黏液（Mucus）

肠道分泌的滑性液体；尿液中出现黏液丝属正常现象。

会疼吗？ 手术在全身麻醉下进行，术中您不会有任何感觉。术后会有腹部酸痛，肠道需要数天才能“苏醒”恢复功能。术后您会带着插入新膀胱的导尿管（约保留 2–3 周）及软支架管。多数患者住院约 5–8 天；手术本身时间较长。

如何准备（术前）

- 手术在**全身麻醉**下进行——请遵守所有术前指示（禁食、按医嘱停用抗凝药）。可能需要进行**肠道准备**。
- 充分了解术后承诺：需**白天和夜间定时排尿**、可能需要**自我导尿**，以及坚持盆底肌锻炼。
- **戒烟**，并提前安排好术后的照护支持。

请提前告知您的医疗团队，如果您：

- 正在服用**抗凝药**，或目前有感染
- 有**肠道疾病**或肾脏问题，或曾接受腹部手术或放疗

手术过程

- 1 全身麻醉起效后，给予预防性抗生素。
- 2 截取一段肠道备用，其余肠道重新吻合。
- 3 将截取的肠道展开并折叠成储尿囊，缝合至尿道。
- 4 将输尿管接入储尿囊；放置导尿管和软支架管，待其愈合。

之后

- 约 **5–8 天**后出院，携带导尿管回家（保留约 **2–3 周**）；可冲洗导管以清除黏液。
- 拔管前需进行**愈合 X 线检查**，确认新膀胱无漏。
- 拔管后学习**定时排尿**（设置夜间闹钟）、盆底肌锻炼，以及必要时的**自我导尿**。
- 早期（尤其夜间）可能出现**漏尿**，数月后逐步改善。黏液属正常现象，需多饮水，并需**终身随访**（包括监测维生素 B12）。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或畏寒
- **无法排尿**或导尿管**停止引流**
- 剧烈腹痛、呕吐，或**无排气排便**
- 大量出血、伤口红肿或渗液，或腰背部疼痛

需要记住的三件事

1. 新膀胱由肠道制成并与尿道相连，可自然排尿，无需造口袋。
2. 需要练习：白天和夜间定时排尿、盆底肌锻炼，有时需自我导尿。控尿能力会逐步改善，早期漏尿属正常现象。
3. 术前遵守禁食及肠道准备指示，戒烟。保留导尿管至医生在愈合 X 线确认后拔除；若无法排尿或导尿管停止引流，请立即联系医疗团队。